

TFP — Kernberg

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (ang. *Transference-Focused Psychotherapy*). 2–3 sesje/tydzień, 2–5 lat. Adaptacja dla NPD: TFP-N (Diamond 2022). Praca z przeniesieniem „tu i teraz”.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Yeomans i wsp. (2015); Levy i wsp. (2006); Diamond (2022)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz *centralną technikę* TFP — pracę z przeniesieniem w „tu i teraz” (sekcja 01). **2** · Poznasz trzy elementy ramy: *kontrakt*, *setting*, *analiza* (sekcja 02). **3** · Zobaczysz, jak idealizacja i dewaluacja *terapeuty* stają się materiałem do pracy (sekcja 03). **4** · Poznasz dowody skuteczności i warunki kwalifikacji (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Transference-Focused Psychotherapy (TFP) to ustrukturyzowana psychoanalityczna terapia opracowana przez **Kernberga, Yeomansa i Clarkina** dla pacjentów z zaburzeniem osobowości borderline (BPD); **adaptacja dla NPD** (TFP-N) opisana przez Diamond i wsp. (2013, 2022). Najsilniejsza empirycznie metoda dla zaburzeń klastra B, z randomizowanymi badaniami kontrolowanymi wykazującymi przewagę nad leczeniem standardowym (TAU) i innymi protokołami w BPD. *Centralna technika*: praca z **przeniesieniem** (ang. *transference*) — wzorce relacyjne pacjenta *odtwarzają się* w relacji z terapeutą („mikrokosmos” patologii). W NPD: pacjent może *idealizować* terapeutę („najlepszy terapeuta świata!”), a potem nagle *dewaluować* („nic nie rozumiesz, marnujesz mój czas”) albo *rywalizować* z nim. **Terapia interpretuje te wzorce** — zamiast je przegapić jako „normalny” dialog. Levy i wsp. (2006, RCT): TFP istotnie zmienia *styl przywiązania* — 24% pacjentów z BPD przechodzi z niebezpiecznego do bezpiecznego stylu w ciągu roku terapii. Poprawia *mentalizację*. Clarkin i wsp. (2007): TFP wykazała wyższość nad DBT i psychodynamiką wspierającą w niektórych wymiarach (organizacja osobowości, agresja). Diamond i wsp. (2022): otwarte badanie TFP-N dla NPD — obiecujące efekty. *Mechanizm zmiany*: przeniesienie aktywuje wzorzec relacyjny w *gabinecie* — pacjent odtwarza z terapeutą cykle splittingu, dewaluacji, idealizacji. Terapeuta *nazywa* i *interpretuje* te cykle. Przez powtórzenie pacjent uczy się je rozpoznawać i modyfikować. Trzy fazy interpretacji Kernberga: **klaryfikacja** (co się dzieje?), **konfrontacja** (zauważ sprzeczność), **interpretacja** (skąd to się bierze?). *Wymagania*: wykwalifikowany terapeuta (długie szkolenie TFP), motywacja pacjenta (kontrakt!), ramy strukturalne (regularność, opłata, granice). **Nie dla wszystkich pacjentów z NPD** — niezbędna motywacja i pewna zdolność refleksji.

01



Centralna technika — praca z przeniesieniem

CO TO ZNACZY

Wzorce relacyjne *odtwarzają się* z terapeutą. Splitting, dewaluacja, idealizacja — **w sesji**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Sesja = *mikrokosmos* patologii. Nazywanie wzorców „**tu i teraz**” silniejsze niż omawianie wczoraj.

02 ☉ Trzy elementy ramy TFP

1 · KONTRAKT

Jasny dokument na start: czas sesji, opłaty, zasady kontaktów między sesjami, kryteria zakończenia, plan awaryjny w kryzysie. *Negocjowany na pierwszych 2-4 sesjach.*

2 · SETTING

2-3 sesje/tydzień. Te same dni, godziny, miejsce. Niezmiennność ramy *jest* terapeutyczna — daje strukturę, której pacjent z NPD nie miał w dzieciństwie.

3 · ANALIZA W „TU I TERAZ”

„Co się dzieje między nami teraz?” Trzy fazy: klaryfikacja → konfrontacja → interpretacja. *Nie* omawiamy wczorajszego dnia — nazywamy, co dzieje się w pokoju.

03 ✎ Idealizacja i dewaluacja terapeuty — materiał do pracy

FAZA IDEALIZACJI

„Najlepszy terapeuta świata!” Pacjent czuje się *wyjątkowy/-a*, bo trafił/-a na wyjątkowego terapeuty. Terapeuta zauważa ostrożność: *idealizacja zawsze prowadzi do dewaluacji.*

FAZA DEWALUACJI

„Nic nie rozumiesz, marnujesz mój czas, jesteś niekompetentny/-a.” **Test:** czy terapeuta wytrzyma bez wycofania albo odwetu? Jeśli tak — formuje się nowe doświadczenie relacyjne.

Diamond i wsp. (2014, 2022): początkowa idealizacja terapeuty *prawie zawsze* prowadzi do dewaluacji — i **tu zaczyna się prawdziwa praca**. Pacjent uczy się: „*mogę być wściekły i nie zostanę odrzucony*”. To jeden z kluczowych mechanizmów zmiany w TFP.

04 💡 Skuteczność i kwalifikacja

SKUTECZNOŚĆ

Levy 2006: 24% pacjentów BPD zmienia styl przywiązania z niebezpiecznego na bezpieczny w ciągu roku. Clarkin 2007: wyższość nad DBT i terapią wspierającą w niektórych wymiarach. Diamond 2022: TFP-N obiecujące dla NPD.

KWALIFIKACJA

Konieczne: motywacja pacjenta, pewna zdolność refleksji, możliwość 2-3 sesji/tydzień przez 2-5 lat, wykwalifikowany terapeuta TFP. **Nie dla wszystkich** z NPD — wymaga zaangażowania.

Klucz: TFP jest *intensywna* — wymaga solidnego zaangażowania pacjenta i wykwalifikowanego terapeuty (długie szkolenie). Standardowa CBT albo psychodynamika krótkoterminowa *nie sięga* organizacji osobowości — pacjent zyskuje narzędzia, ale strukturalnie pozostaje narcystyczny. TFP pracuje na poziomie **strukturalnym**: zmiana organizacji reprezentacji obiektowych. Wynik: remisja strukturalna u ~50% pacjentów (Yeomans 2015) — *najbardziej trwała* zmiana dostępna dla NPD. Adaptacja dla NPD (Diamond 2022, TFP-N) zachowuje strukturę z dodatkową uwagą na wstyd i idealizację/dewaluację terapeuty. **To metoda dla pacjentów z motywacją do długiej, wymagającej pracy** — nie pierwsza linia dla osoby zaczynającej terapię.